

Fecha Última Actualización: 25-03-2022 10:35:39

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Betzabe Del Transito Urbina Manriquez **Rut** : 8.168.855-9 **N° Archivo** : 2203906 **N° Epicrisis**
Edad : 66a 4m 12d **Fecha Nacto**: 13/11/1955 **Sexo** : Femenino **299497**
Dirección : Av.Ejercito Libertador 3899 Cond. Los Coi **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 981942386-984134623

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 02/03/2022 20:15 **Días Estadía**: 23
Unidad de Egreso : Medicina Cuidados Básicos 5° Piso **Fecha Egreso** : 25/03/2022 09:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Betzabe del Tránsito Urbina Manriquez
RUT: 8168855-9
Edad: 66 años
FI CASR: 02/03/22
FI UTIM: 15/03/22
Contacto: 981942386 (hija)

Antecedentes:

- Médicos: Artritis Reumatoide, Obesidad mórbida, SAHOS (refiere indicación de CPAP pero sin controles posteriores) HTA.
- Quirúrgicos: Histerectomía, Colectectomía, Artroplastia de rodilla.
- Fármacos: Prednisona, Losartán, Metotrexato, Sulfasalazina (se desconoce dosis)
- Alergias: Niega
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), Drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: No
- Social: Vive con hija en Puente Alto
- Inmunizaciones: COVID 19 3 dosis, Flu 2021 (+), Neumococo 2020 (+).

RESUMEN:

Paciente con antecedentes descritos, con fecha de inicio de síntomas el 24/02. Se realiza PCR COVID ambulatoria positiva. Derivada a domicilio donde evoluciona con dificultad respiratoria, sensación febril y episodio de desaturación, por lo que se traslada a SAPU de donde es derivada al SU HSR por altos requerimientos de oxígeno. Ingresa al SU en regulares condiciones generales, con requerimientos de 15 lts por MNRC, con mala mecánica ventilatoria y aumento progresivo de requerimientos de O2, parametros inflamatorios elevados y acidosis respiratoria que se profundiza por lo que se decide VMI el 03/03 e ingreso a UPC.

Exámenes al ingreso: GSA: pH 7.36 PaO2 37.7 CO2 36 HCO3 20.2 Hb 12.4 GB 14730 RAL 400 RAM 14000 PLQ 416.000 TTPA 32.9 INR 1.06 Crea 1.5 BUN 21.5 ELP 134/4.07/102 PCR 407.8

Imagenes al ingreso:

Fecha Epicrisis : 25/03/2022 10:35

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:45

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

AngioTC 02/03: Signos de neumopatía multifocal pulmonar bilateral, con patrón altamente sospechoso de neumonía en COVID-19.

Diagnósticos de ingreso:

1. Insuficiencia respiratoria aguda
 - a. NAC COVID FIS 24/02
 - b. Call C alto riesgo de progresión de la enfermedad.
 - c. Inmunosupresión farmacológica
2. AKI KDIGO II obs en contexto de sepsis.
3. Antecedentes: AR, SAHOS, obesidad, HTA.

Evolución durante la hospitalización:

1. Hemodinamia: Al ingreso hemodinámicamente estable, durante estadía en UPC con requerimientos de dosis bajas de NAD en relación a sedoanalgesia que se suspenden precozmente. Se decide traslado a UTIM 15/03, donde en contexto de fiebre e hipotensión cursa con shock séptico, por lo que se inicia NAD para metas de PAM 65/70 mmHg y monitorización invasiva, posteriormente logra mejoría y suspensión de NAD al día siguiente. 21/03 previo traslado a sala básica, se reinicia VDO los cuales se han ajustado, sin conflicto posterior.

2. Respiratorio: Ingresó con requerimientos de VMI, con ventilación mecánica protectora que requiere ciclo de pronó del 04/03 - 06/03, Bloqueo neuromuscular 03/03-07/03. Con buena evolución gasométrica, se suspende sedación el 09/03 con buena respuesta a ventilación espontánea. Se decide extubación 11/03 con pruebas de ventilación espontánea exitosa. Posteriormente, se apoya con CNAF evolucionando con mala mecánica con fracaso de weaning, por lo que se reintuba el mismo 11/03. Posteriormente, se logra weaning el 14/03 saliendo a VMNI con buena tolerancia. Se traslada a intermedio el 15/03 y en esa unidad presenta deterioro ventilatorio en contexto de shock séptico, sumado a abundantes secreciones y estridor laríngeo, se maneja con NBZ berodual, adrenalina y KNTR con buena respuesta. En contexto de shock se inicia hidrocortisona en dosis de estrés suspendiéndose prednisona. Se realiza IC a ORL por estridor laríngeo que no logra concretarse en hospitalización. Evoluciona de manera favorable, con destete progresivo de oxígeno hasta lograrse suspensión manteniendo buena mecánica ventilatoria. En sala básica se evalúa sin evidencia de estridor se decide suspender dexametasona evolucionando favorablemente sin conflicto posterior.

3. Infeccioso: Al ingreso parámetros inflamatorios elevados, afebril. Se inician corticoides según protocolo RECOVERY completando 10 días. El 09/03 durante estadía en UPC se pesquisa elevación de parámetros inflamatorios, sin fiebre descrita, por lo que se decide pancultivar destacando *Pseudomona putida* en CAET y *E. coli* MS en urocultivo. Se interpreta como Neumonía asociada a ventilación mecánica e ITU respectivamente, por lo que se inició Ceftazidima el 10/03 completando 7 días. HC positivo para *S. epidermidis* que se interpreta como contaminación. Al ingreso a UTIM (17/03) evoluciona febril hasta 37.7°C y con parámetros inflamatorios al alza, por lo que se pancultiva. Se inicia manejo con Imipenem/Vancomicina (FI 17/03), con evolución favorable. Se retira CVC (20/03). Dado cultivos negativos, se decide suspender vancomicina al 4to día y se completan 7 días de imipenem (24/03). Sin conflicto posterior.

4. Renal/Medio Interno: Creatinina elevada al ingreso sin basal conocido, que se interpreta como AKI. Al ingreso a UTIM destaca alcalosis metabólica, impresiona en contexto de VEC bajo, además hipokalemia que revierte con medidas farmacológicas. Posteriormente evoluciona tendiente a hipernatremia que corrige con aumento de aportes de agua libre vía oral.

5. Reumatológico: Paciente usuaria de corticoides de manera crónica, por presencia de shock séptico se iniciaron dosis de estrés con hidrocortisona que se mantiene posteriormente con dexametasona por estridor laríngeo. Sin evidencia de insuficiencia adrenal se decide suspender dexametasona el 22/03 y se reinicia prednisona en dosis habituales de ambulatorio. Sin conflicto posterior. Reiniciar DMARD al alta.

6. Delirium: Al ingreso a UTIM impresiona en contexto tóxico metabólico, manejándose en primera instancia con quetiapina, sin embargo se suspende por aumento de sedación y se deja Haldol SOS y medidas ambientales. Con buena respuesta. Posteriormente se decide inicio de risperidona que se suspende posteriormente en sala básica. Sin conflicto ulterior.

Diagnósticos de egreso:

Fecha Epicrisis : 25/03/2022 10:35

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 25-03-2022 10:35:39

Página 3 de 4

1. Insuficiencia respiratoria aguda resuelta
 - a. NAC COVID grave FIS 24/02 recuperada
 - VMI 03/03-14/03 // Prono 04/03-06/03 // BNM 003/03-07/03
 - Inmunosupresión farmacológica
2. Sepsis de foco no precisado resuelta
3. NAVM Pseudomona putida tratada
4. ITU E. coli tratada
5. AKI KDIGO II prerrenal resuelta
 - Alcalosis metabólica en contexto de uso de diuréticos resuelta.
 - Hipernatremia leve asintomática resuelta. Hipokalemia leve.
6. Antecedentes: AR, SAHOS, obesidad, HTA.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria Aguda - Covid 19

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

En condiciones de alta hospitalaria para continuar hospitalización domiciliaria. Vigil, OTE sin requerimientos de oxígeno suplementario

Plan Post Alta

Alta con Hospitalización domiciliaria para:

Continuar rehabilitación respiratoria, motora y fonoaudiología por 2 semanas

Posteriormente continuar en sala RBC de su CESFAM (Llevar epicrisis para ingreso y garantizar kinesioterapia respiratoria y motora)

Reposo relativo

Regimen hiposódico, bajo en grasas y en carbohidratos simples

Medicamentos:

Prednisona 5 mg/día VO

Berodual 2 puff cada 8 hrs con aerocámara

Losartán 50 mg c/12 hrs VO

Levotiroxina 125 mcg al día VO

Metotrexato 8 comprimido VO todos los viernes (autorizado previamente por Reumatólogo)

Azulfidine 1 g cada 24 horas VO

Controles por Reumatología habituales (H Salvador)

Controles por Broncopulmonar habituales (H Salvador)

Si presenta dificultad respiratoria, fiebre, vómitos, compromiso del estado general, mala tolerancia a vía oral u otros síntomas presentados al momento del alta favor reconsultar al servicio de urgencia.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

S/F - Libre Elección - - Reumatología en Hospital Del Salvador

S/F - Libre Elección - - Control con Broncopulmonar en Hospital del Salvador para manejo de SAHOS

Fecha Epicrisis : 25/03/2022 10:35

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:45

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



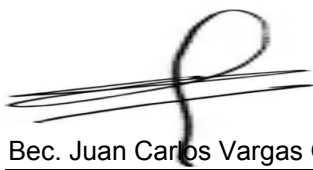
COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 25-03-2022 10:35:39

Página 4 de 4



Bec. Juan Carlos Vargas Guerrero

Becado/Residente



Alberto Saffatis Feige

Médico Tratante (Staff)

INTERNO